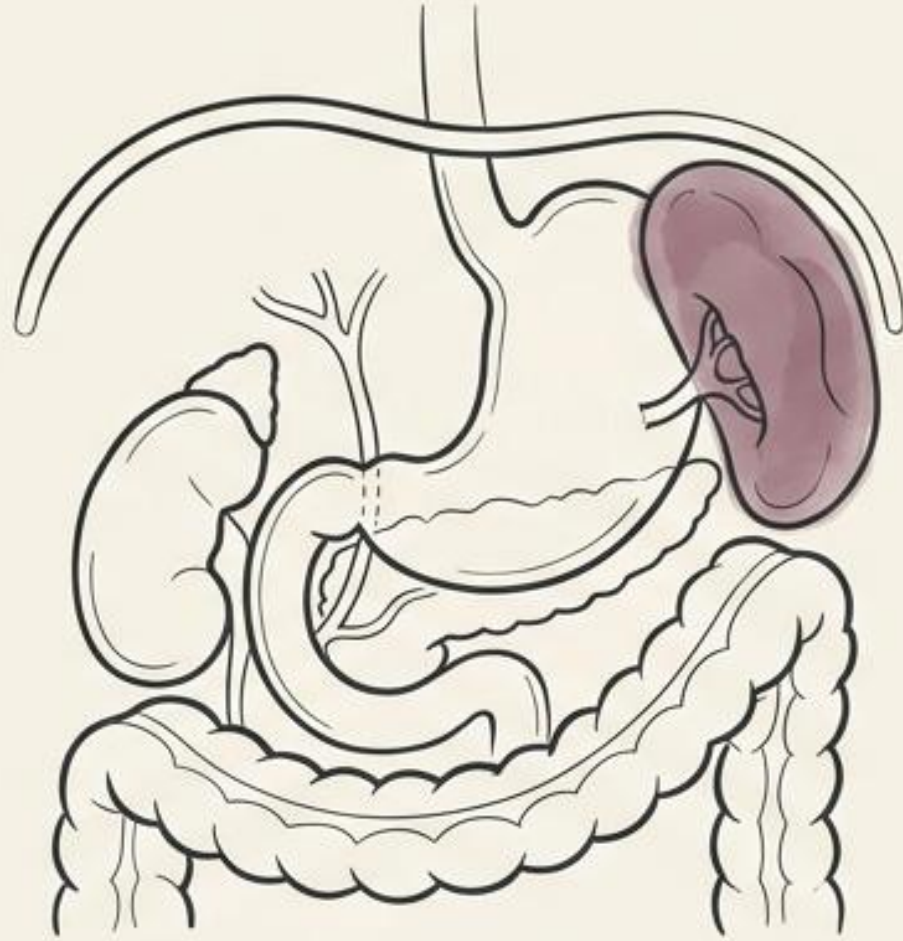
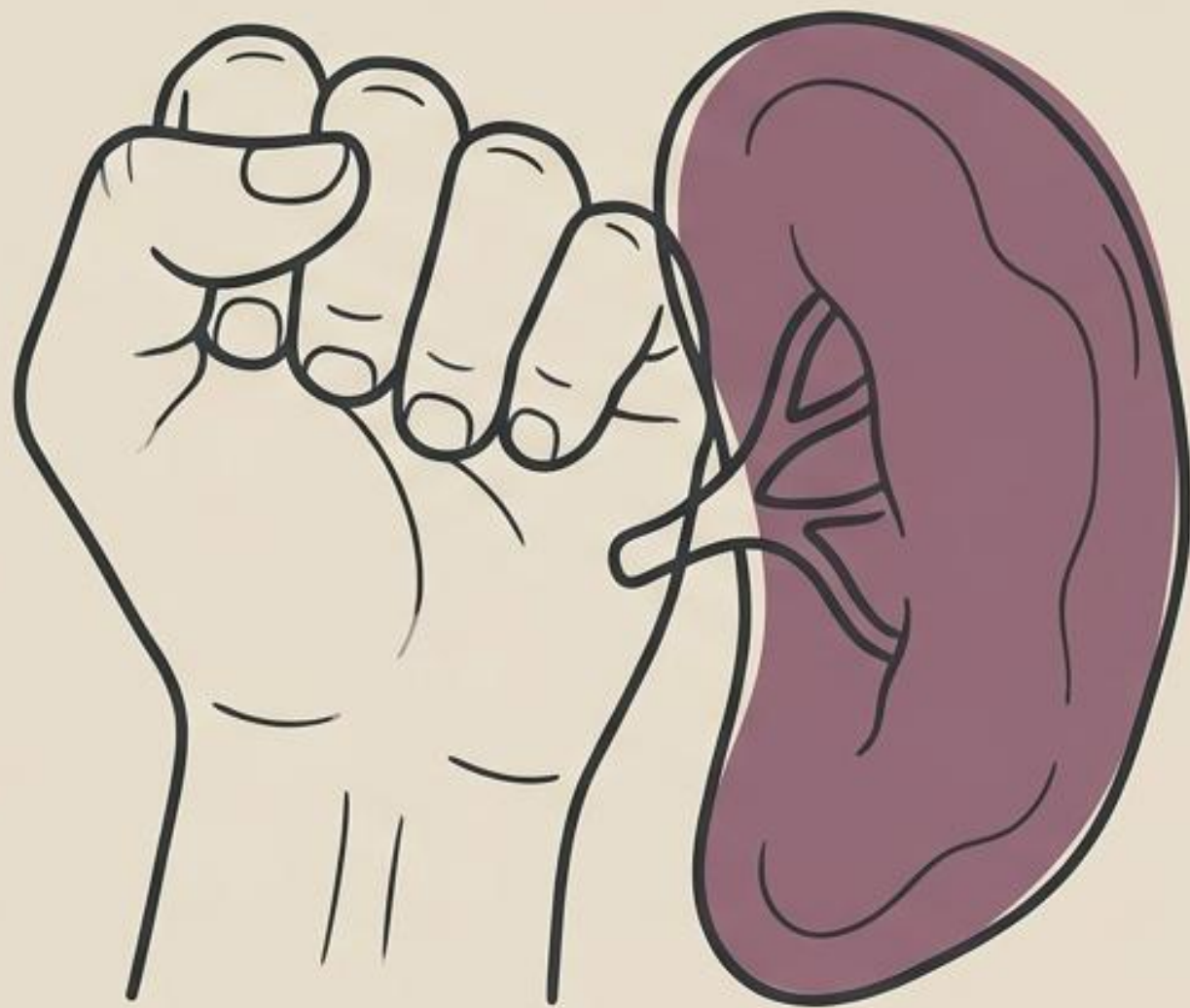




La Rate

Architecture Viscérale et Lecture Clinique ROP

Identité et Fonctions Premières



Poids moyen : ~150 g (variabilité selon les individus).

Taille : 10 à 12 cm de long (taille d'un poing).

Morphologie : Forme ovoïde, consistance molle et très fragile.

Réseau : Voie sanguine exclusive (aucun canal excréteur, pas de voie lymphatique directe).



Épuration
(Phagocytose des
hématies usées)



Immunité
(Défense
anti-infectieuse)



Réservoir
(Régulation sanguine
et plaquettaire)

Profil Physiologique



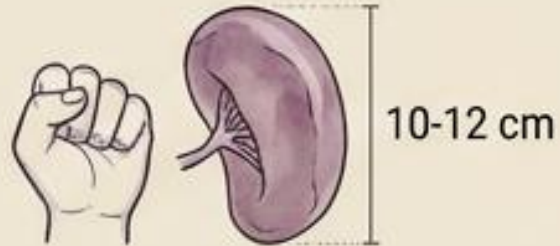
Morphologie

Poids moyen : ~150 g (fortes variations individuelles).

Dimensions : 10 à 12 cm de long (taille d'un poing).

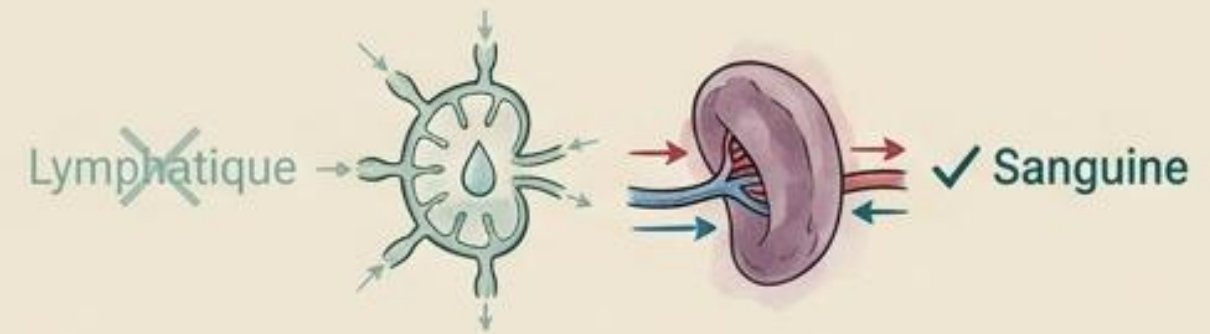
Forme : Ovoïde, couleur violacée.

Consistance : Molle, fragile, vulnérable aux traumatismes.



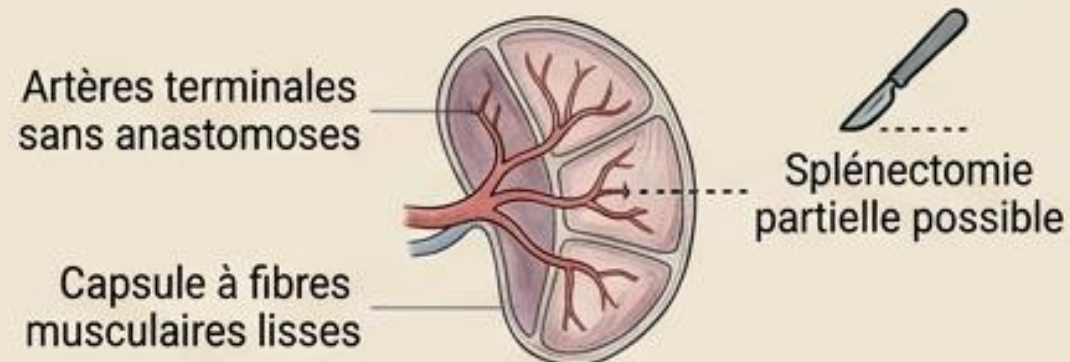
Typologie

Organe lymphoïde, mais fonctionnant exclusivement par voie sanguine (non lymphatique).



Spécificité

Aucun canal excréteur. Artères terminales sans anastomoses (permettant la splénectomie partielle).
Compartimentée par une capsule à fibres musculaires lisses.



Rôles Principaux

- **Phagocytose et épuration cellulaire**
- **Défense immunitaire**
- **Réserve et filtration sanguine**
- **Hématopoïèse** (vie fœtale uniquement)



Topographie Viscérale

Voûte

Située sous l'hémi-coupole diaphragmatique gauche (partie postéro-supérieure de l'abdomen).

Protection Osseuse

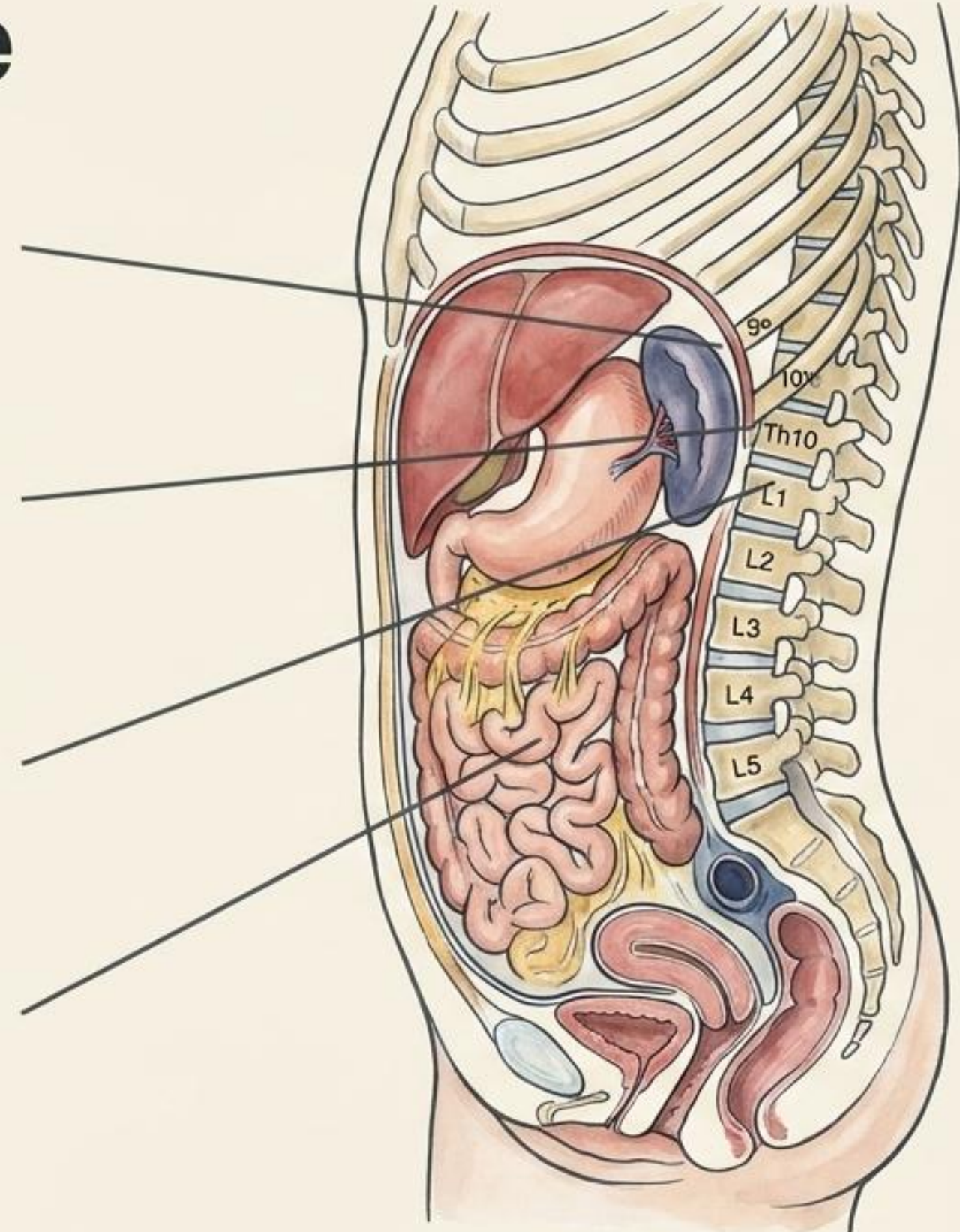
Recouverte par la partie latérale inférieure du thorax (9^e, 10^e et 11^e côtes gauches). Le grand axe suit la 10^e côte.

Repères Axiaux

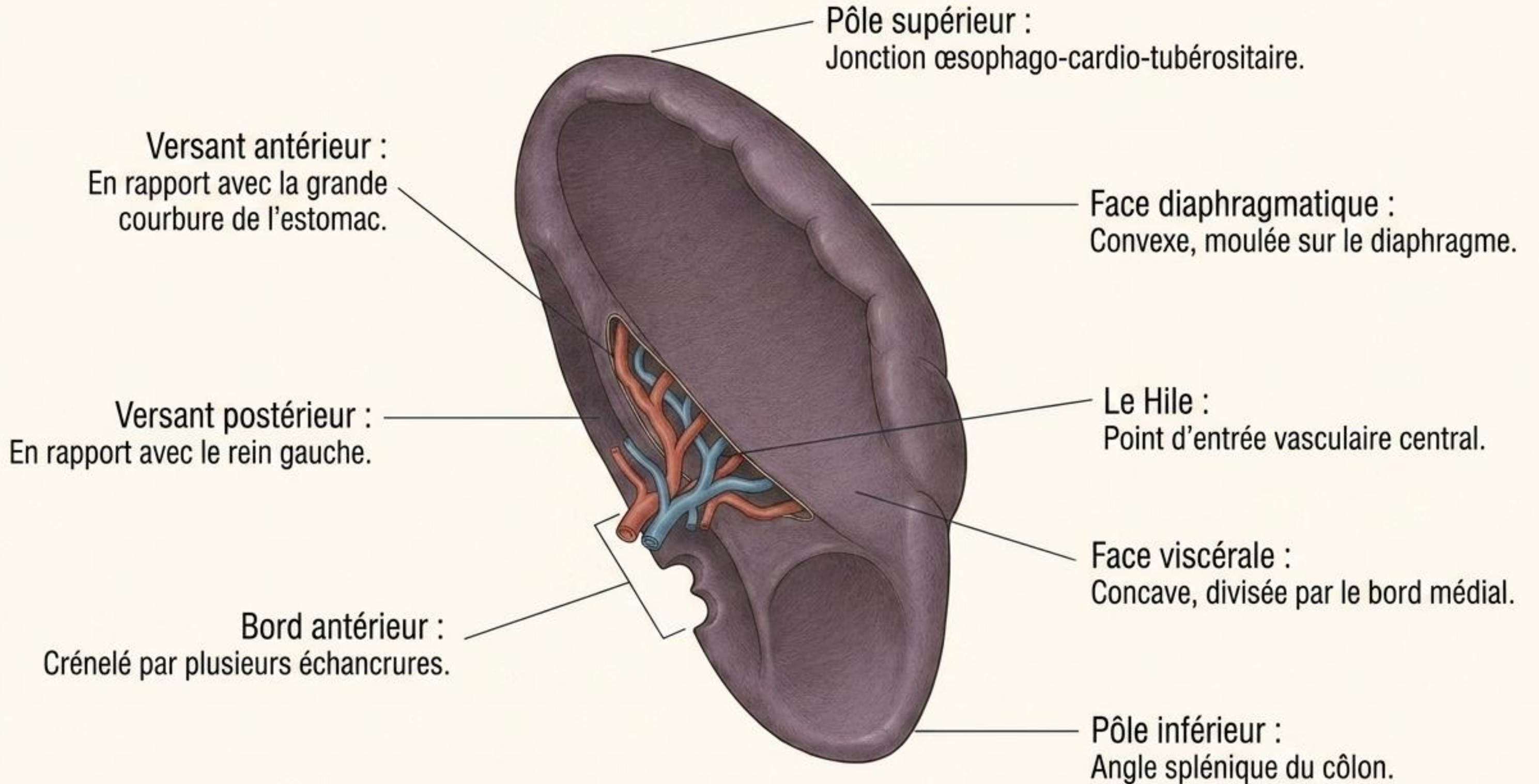
En arrière de la ligne axillaire antérieure, à environ 2 cm de l'apophyse transverse de Th10.

Péritoine

Entièrement intra-péritonéale (sauf au niveau de son hile).

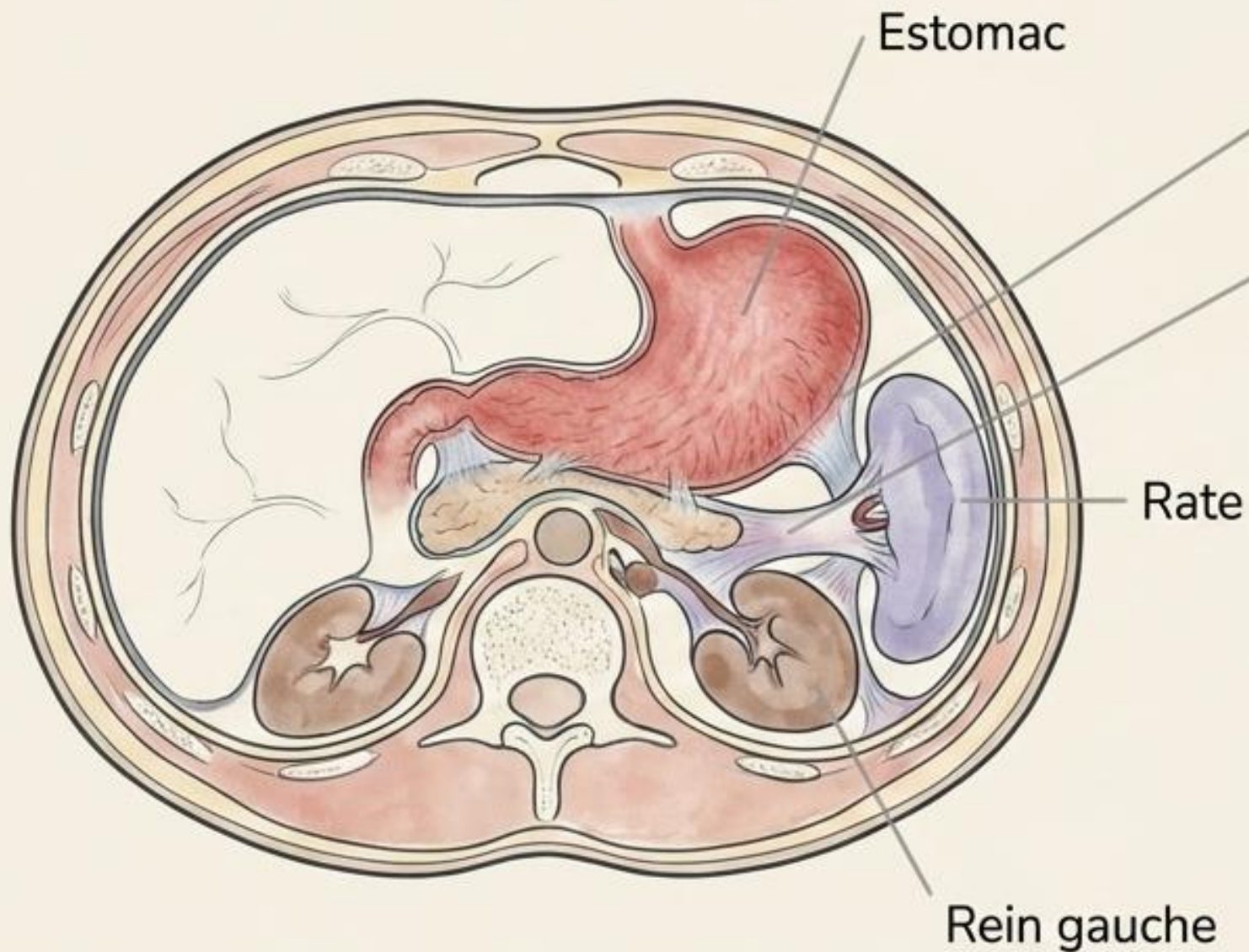


Morphologie Externe et Faces



Le Réseau de Fixité (Suspension Viscérale)

La rate est peu fixée, ce qui lui permet de suivre intimement les mouvements du diaphragme.

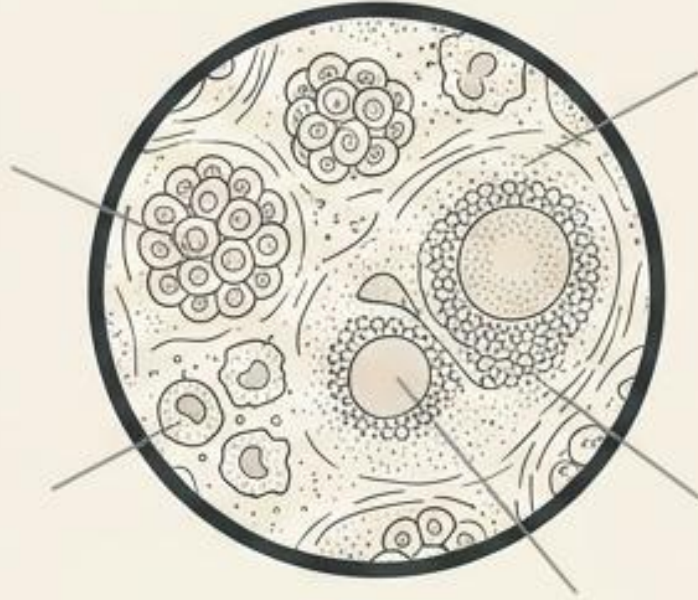


Les 5 Ligaments :

- **À l'Estomac** : Ligament gastrosplénique (antérieur au hile).
- **Au Pancréas** : Ligament pancréaticosplénique (postérieur au hile, logeant la queue du pancréas).
- **Au Côlon** : Ligament phrénocolique (sert de plancher à la rate).
- **Au Diaphragme** : Ligament phrénosplénique / suspenseur (s'oppose au glissement vers le bas).
- **Au Rein Gauche** : Ligament splénorénal.

Note Clinique : Le pédicule vasculaire participe également à l'attache de l'organe.

Dualité Tissulaire : Pulpe Blanche et Pulpe Rouge



Pulpe Blanche (Tissu Lymphoïde)

Rôle : Défense immunitaire active.

Acteurs : Lymphocytes T et B, macrophages.

Cibles : Phagocytose des agents pathogènes et des débris cellulaires. Lutte contre les infections.



Pulpe Rouge (Filtre Sanguin)

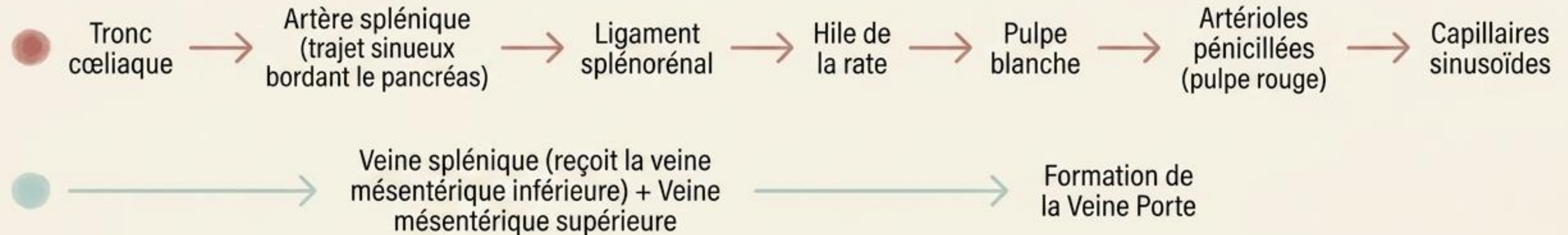
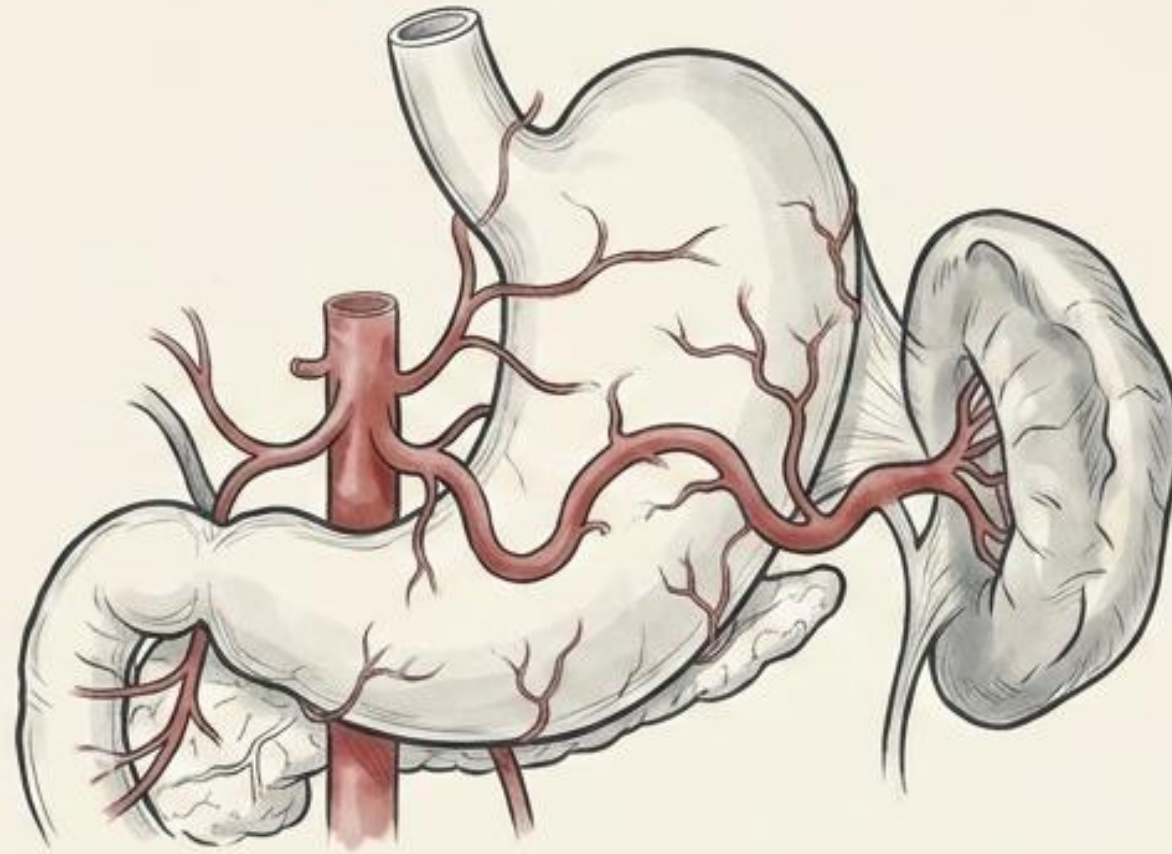
Rôle : Épuration et hémolyse physiologique.

Mécanisme : Récupération du fer (dirigé vers le foie puis la moelle osseuse).

Cibles : Élimination des hématies âgées, altérées, ou malformées, et des plaquettes détériorées.

Chez l'adulte, la fonction d'hématopoïèse (active in utero) disparaît et ne réapparaît qu'en cas de pathologies extra-médullaires spécifiques.

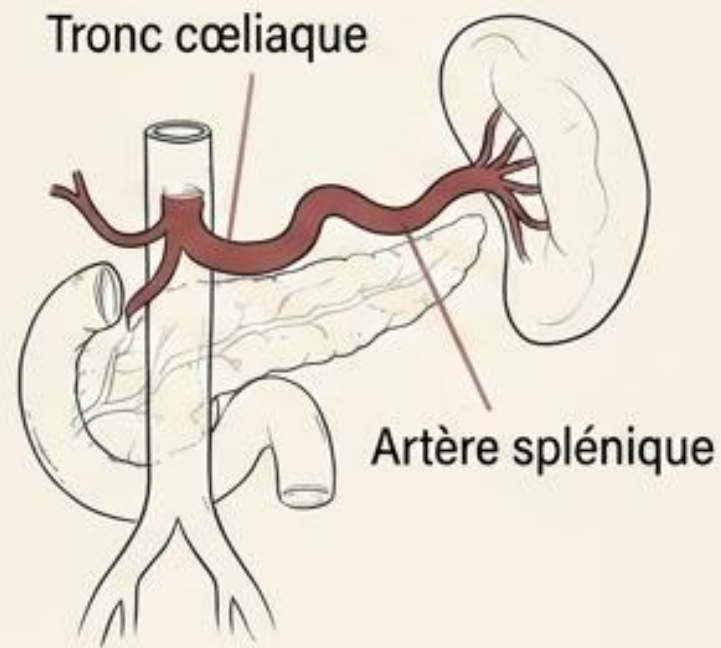
Vascularisation : Le Réseau Sanguin



L'artère splénique est la plus grosse branche du tronc coélique. Ce réseau dense assure la fonction de filtration et d'épuration avant le drainage portal.

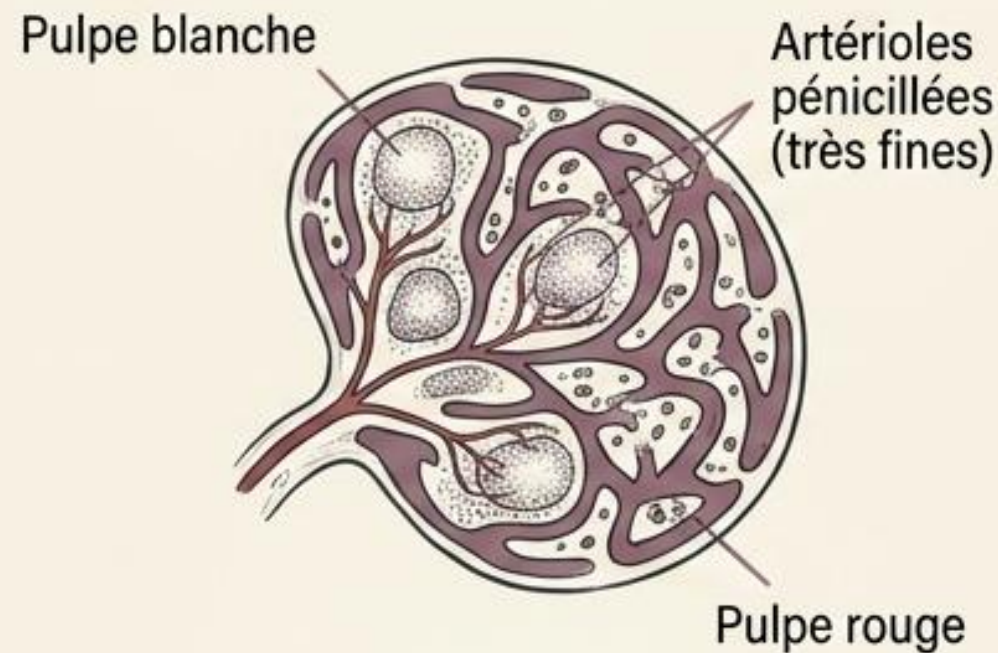
Le Réseau Vasculaire : Artériel et Veineux

Entrée Artérielle



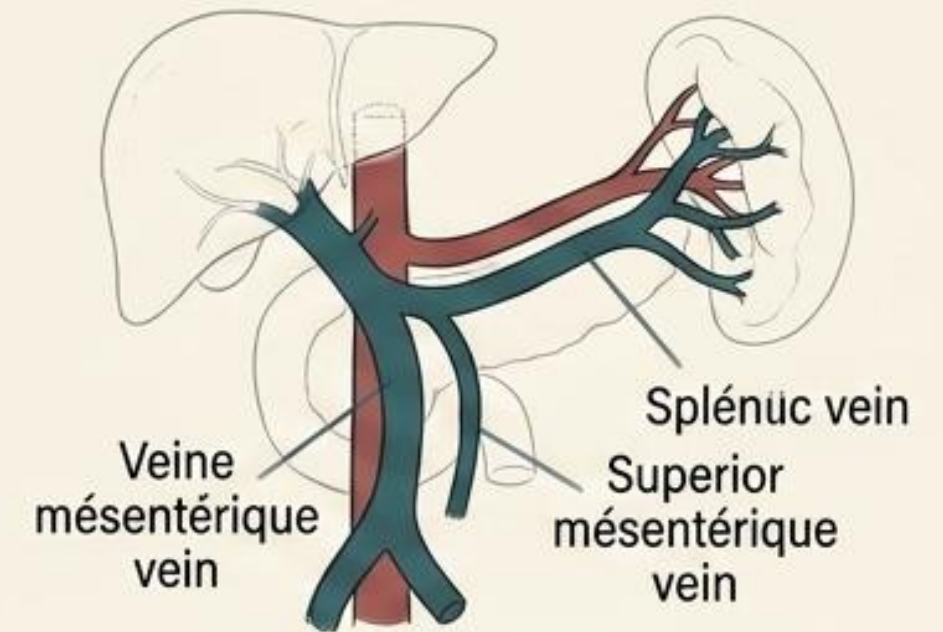
Tronc cœliaque → Artère splénique
(la plus grosse branche, trajet sinueux
au bord supérieur du pancréas)
→ Division au hile.

Filtration Parenchymateuse



Pulpe blanche → Artéριοles pénicillées
(très fines) → Réseau sinusoïde
(pulpe rouge).

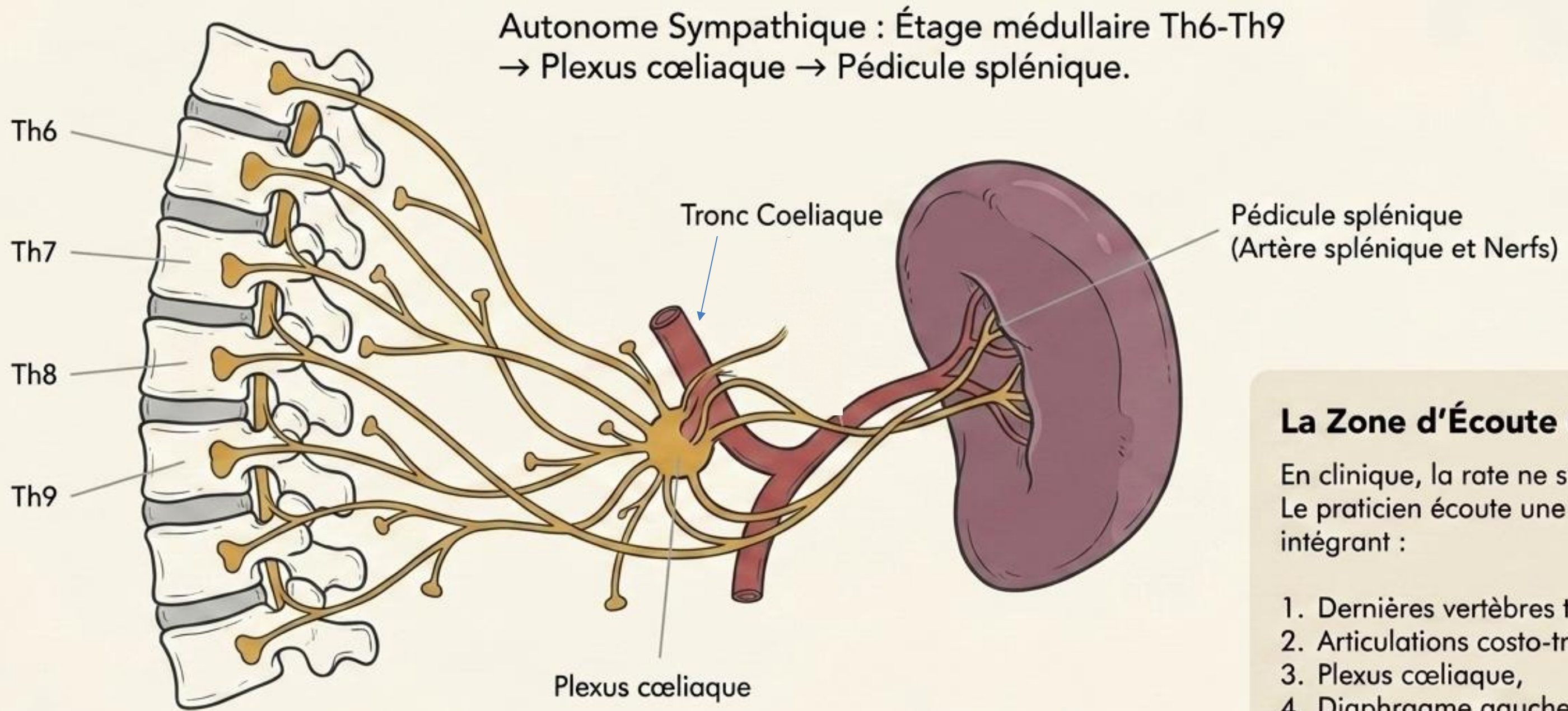
Sortie Veineuse



Veines efférentes → Veine splénique
(reçoit la veine mésentérique inférieure)
→ Fusion avec la mésentérique supérieure
→ Veine porte.

Note clinique : L'absence d'anastomoses entre les artères spléniques terminales permet une splénectomie partielle en cas de lésion.

Innervation et « Zone d'Écoute » ROP



La Zone d'Écoute (ROP)

En clinique, la rate ne s'isole pas.
Le praticien écoute une zone globale intégrant :

1. Dernières vertèbres thoraciques,
2. Articulations costo-transversaires,
3. Plexus coeliaque,
4. Diaphragme gauche,
5. Pédicule splénique

Matrice Fonctionnelle : Le Parenchyme Splénique

Les deux tissus de la rate remplissent des fonctions complémentaires.

Pulpe Blanche (Immunité)



- Composition : Tissu lymphoïde (Cellules T, B, et macrophages).
- Fonction Clé : Lutte contre les infections.
- Action : Phagocytose des débris cellulaires et destruction des agents pathogènes.

Pulpe Rouge (Filtration)



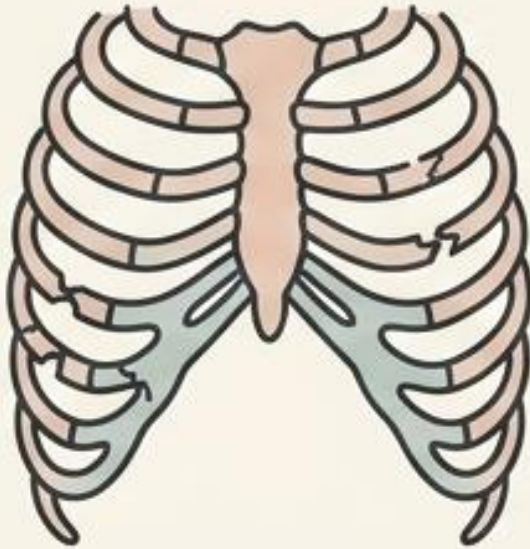
- Composition : Réseau vasculaire et hématies.
- Fonction Clé : Épuration et réserve.
- Action : Destruction des hématies/plaquettes usées.
Récupération du fer (dirigé vers le foie puis la moelle osseuse).

Fonction Foétale : L'hématopoïèse est active pendant la vie foétale, mais exceptionnelle chez l'adulte (pathologie extra-médullaire).

Vulnérabilité et Mécaniques Traumatiques

Contexte : Organe très vulnérable en raison de sa consistance **molle**, de sa **capsule fine** et de sa forte vascularisation. Le risque de rupture constitue une urgence vitale.

Traumatismes Directs



Causes : Fractures costales (9-11), choc abdominal (guidon, volant, coup de poing).

Traumatismes Indirects



Causes : Accidents de voiture, chutes, forte décélération. Lésion splénique possible même sans choc localisé apparent.

Signes d'Alerte : Douleur à l'hypochondre gauche + malaise, pâleur, hypotension, fatigue brutale ou douleur référée à l'épaule gauche.

Diagnostic d'Exclusion : Signes d'Alerte



Clinical Triage Board

La Splénomégalie (Augmentation anormale du volume)

- **Règle clinique** : Une rate perçue sous le rebord costal (surtout à l'inspiration) impose une évaluation médicale.
- **Causes courantes** : Infectieuses (Mononucléose, hépatites), hépatiques (hypertension portale), hématologiques, inflammatoires.



Tableau des Signes d'Alerte Médicale

- Ganglions douloureux (rétro/latéro-claviculaires)



- Pétéchies ou signes de saignement



- Pâleur intense, sueurs nocturnes, fatigue brutale



- Douleurs costales/dorsales spontanées chez l'enfant/ado après un effort bénin.



Traumatismes et Rupture

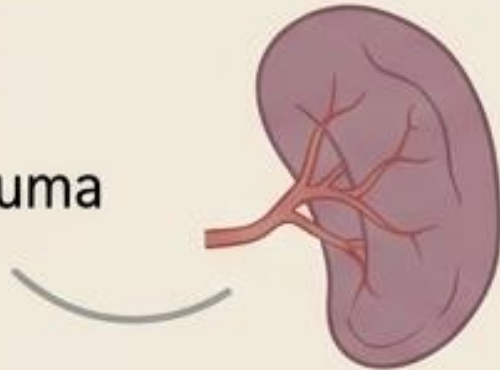
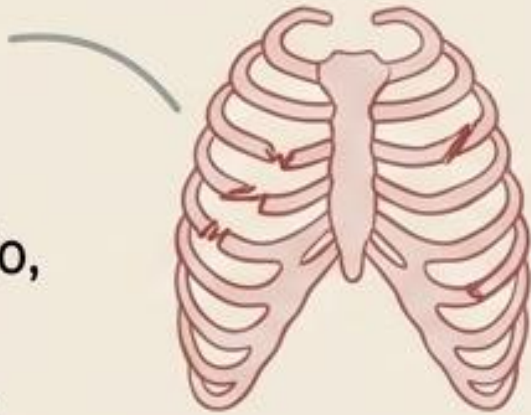
- Très vulnérable aux chocs directs (fractures costales, coups) et indirects (décélération). Risque d'urgence vitale par rupture.



Vulnérabilités : Traumatismes et Mononucléose

Fragilité Mécanique (Traumatismes)

- Organe très vascularisé et de consistance molle.
- **Chocs directs** : Fractures costales, coups, guidon de vélo, volant.
- **Chocs indirects** : Décélération violente, chutes (rupture possible sans plaie apparente).
- **Drapeau Rouge** : Douleur hypochondre gauche post-trauma + malaise, pâleur, ou douleur épaule gauche = Urgence.



Fragilité Virale (Mononucléose)

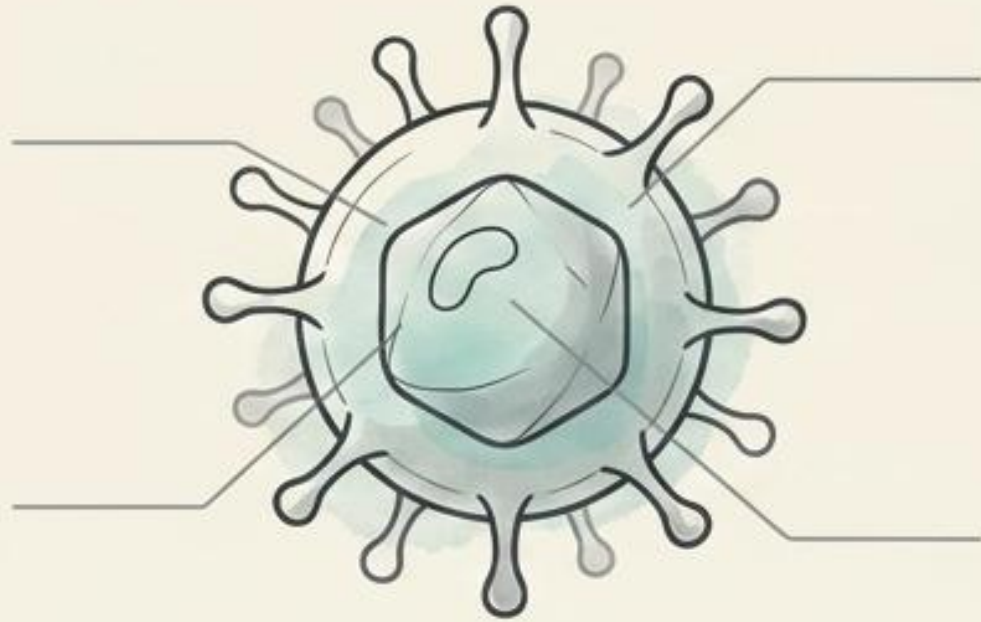
- Virus d'Epstein-Barr (touche souvent adolescents/jeunes adultes).
- **Symptômes** : Angine, fatigue intense, hypotension, dorsalgies nocturnes, points de côté à l'effort.
- Entraîne souvent une augmentation du volume de la rate.



Interdiction stricte des sports de contact, efforts violents ou charges lourdes jusqu'à récupération clinique pour éviter la rupture splénique.

Focus Pathologique : La Mononucléose

Le Profil



Profil : Virus d'Epstein-Barr (famille de l'herpès). Touche particulièrement les adolescents et jeunes adultes.

Check-list Clinique

Symptomatologie Clé :

- Fatigue intense et maux de gorge
- ✓ Hypotension systolique
- ✓ Présence ganglionnaire
- ✓ Dorsalgies nocturnes sans activité préalable
- ✓ Douleur à la compression des côtes inférieures gauches (points de côté).

Règle Pratique ROP : En raison du risque d'augmentation du volume splénique et de rupture, interdiction stricte des sports de contact, efforts violents et charges lourdes jusqu'à récupération clinique totale et avis médical.

Indications ROP et Troubles Fonctionnels

- **Déficits immunitaires** (infections ORL à répétition, surtout chez l'adolescent).
- **Grande fatigue et suites virales** (mononucléose, hépatite).
- **Séquelles mécaniques** (trauma thoraco-abdominal, fractures costales gauches, whiplash).
- **Faiblesse musculaire** (risque d'entorse, jambes lourdes).
- **Point de côté gauche lié à l'activité physique** (typique chez les adolescents).

Le Principe : La prudence s'impose. Une action à distance est toujours privilégiée en ROP pour éviter toute intervention agressive sur un organe fragile, hautement vascularisé et intra-péritonéal.

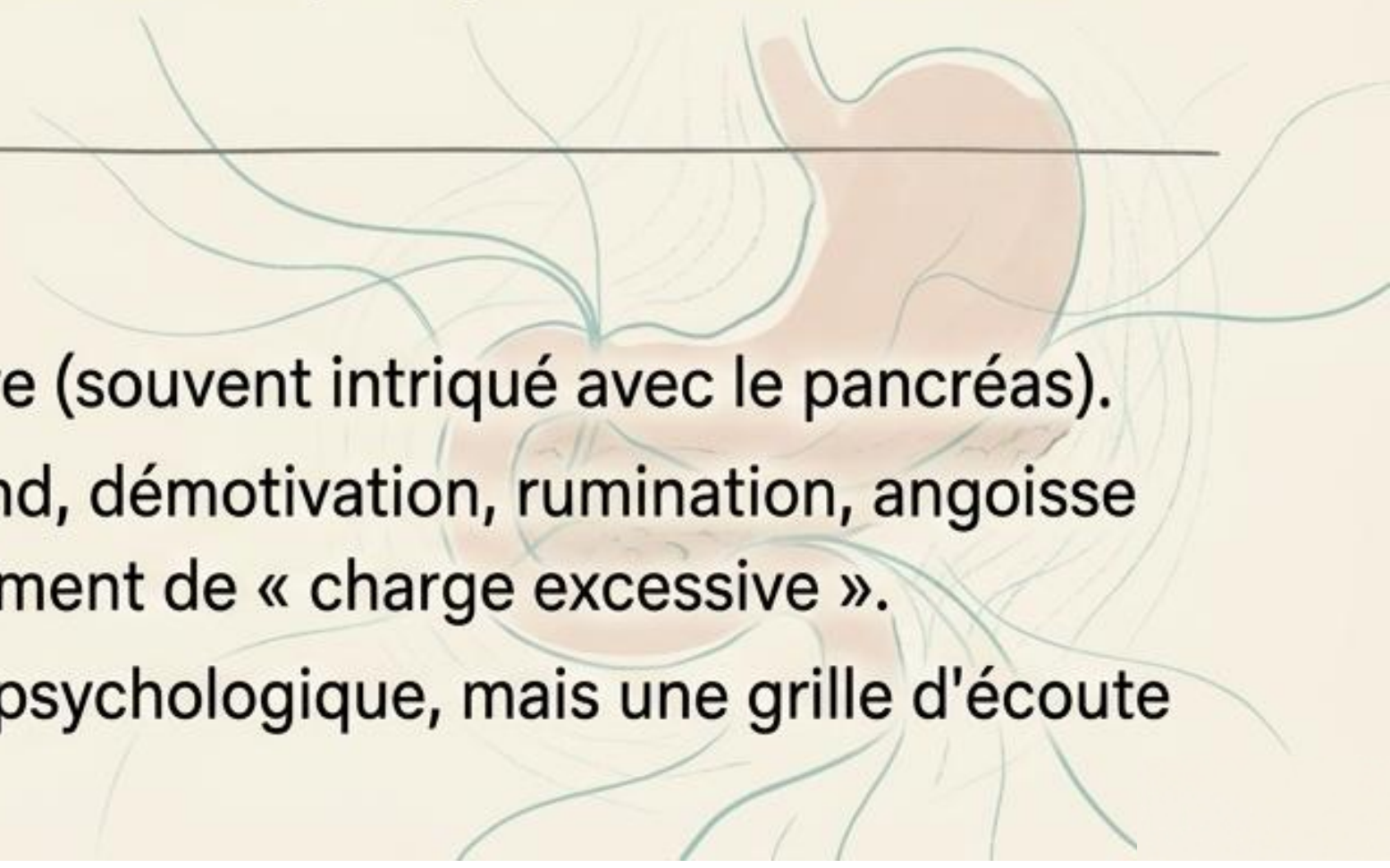
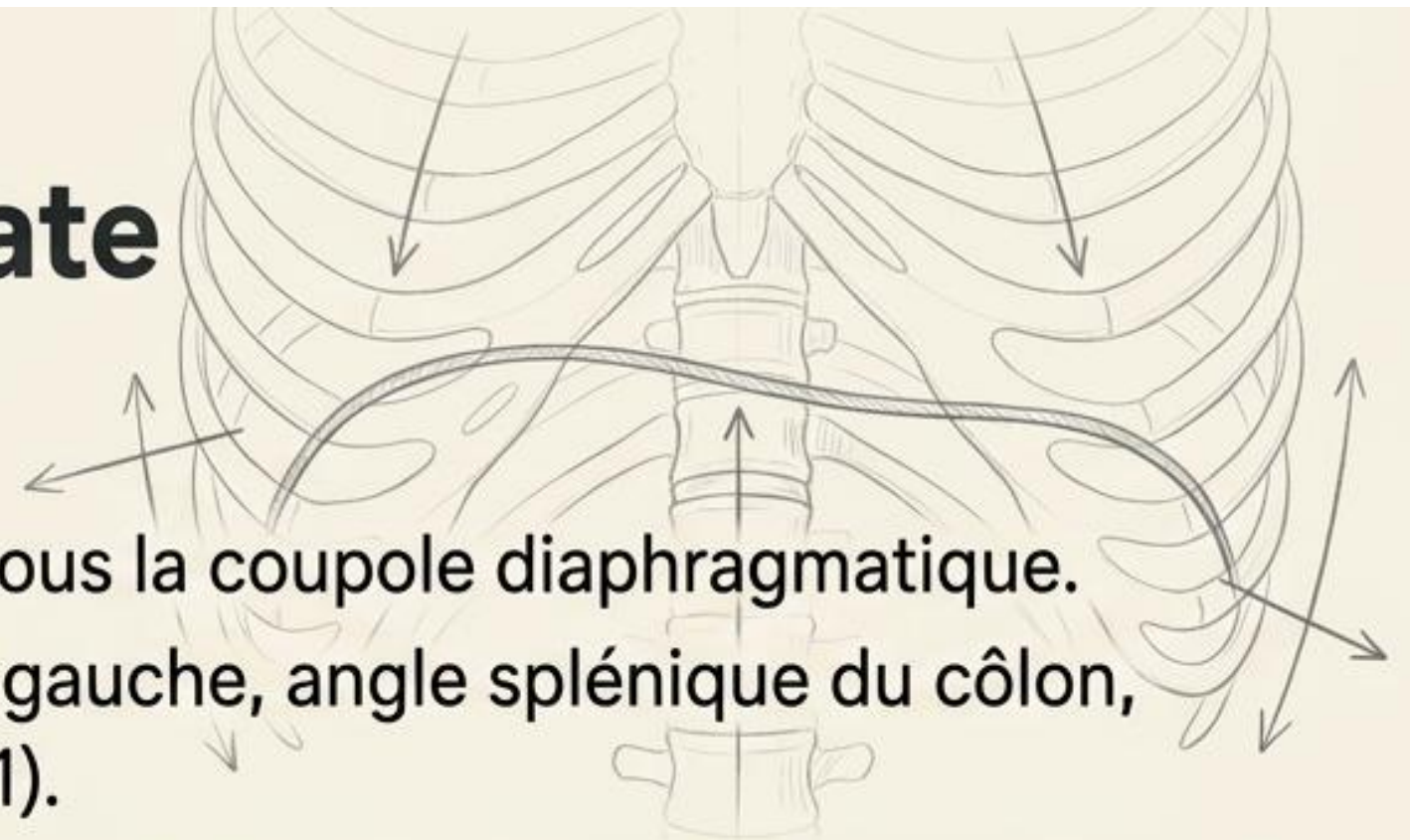
Relations Holistiques de la Rate

Axes Viscéro-somatiques

- **Suspension** : Suit les mouvements respiratoires sous la coupole diaphragmatique.
- **Tensions à rechercher** : Thorax postéro-inférieur gauche, angle splénique du côlon, charnière costo-vertébrale basse (Th9, Th10, Th11).
- **Utilité** : Fil conducteur pour des douleurs costales ou fatigues post-infectieuses sans cause mécanique directe évidente.

Qualité d'Écoute Émotionnelle

- **Symbolique ROP** : Centre énergétique du ventre (souvent intriqué avec le pancréas).
- **Tonalité clinique observée** : Pessimisme profond, démotivation, rumination, angoisse pharyngée, fatigue profonde, remords ou sentiment de « charge excessive ».
- **Note éthique** : Ne constitue pas un diagnostic psychologique, mais une grille d'écoute accompagnant et modulant le soin manuel.



Cartographie Podale : Les Zones Réflexes

Syndrome Loco-Régional

Repérage de la Rate :

- Trouver d'abord l'angle splénique du côlon.
- **Localisation précise** : En position médiale et supérieure à la styloïde du 5e métatarsien gauche.
- **Représentation** : Sous l'extrémité gauche de l'hémi-coupole diaphragmatique réflexe.

Zones Associées à intégrer :

- **Ligaments** : Estomac, pancréas, rein gauche, racine du méso-côlon transverse.
- **Système Porte** : Travailler le lobe gauche et l'ensemble du foie (améliore le retour veineux splénique).

Syndrome Général

Cibler la chaîne latéro-vertébrale Th6-Th9 et le plexus coéliaque.



Cartographie Podale : Zones Réflexes

Syndrome Général d'Adaptation

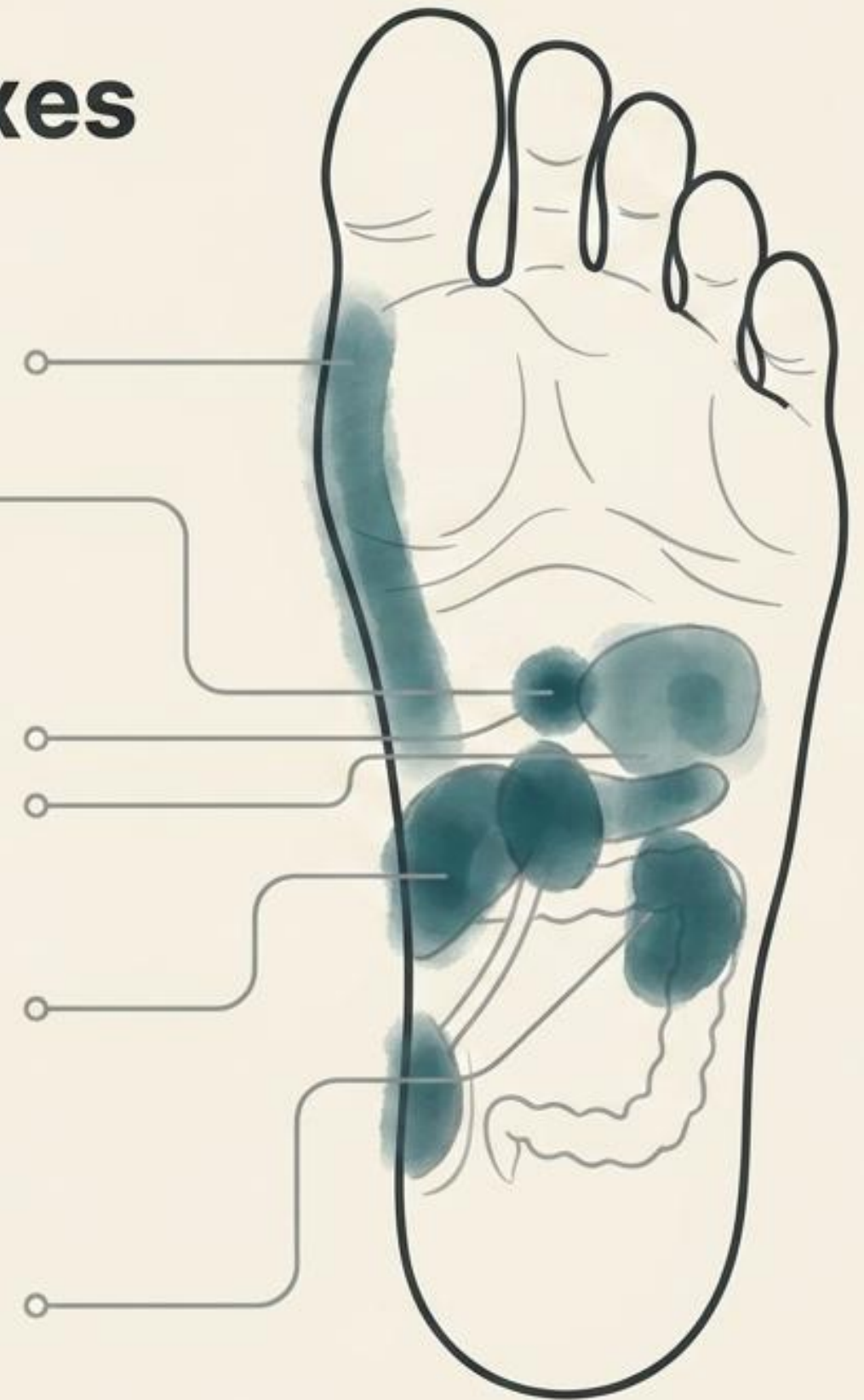
- Colonne et articulations costo-transversaires (chaîne ganglionnaire Th6-Th9).
- Plexus coélique.

Syndrome Loco-Régional

- Organes liés : Estomac, pancréas, rein gauche, racine du méso-côlon.
- Zone Rate : Localisée sur l'angle splénique du côlon (médial et supérieur à la styloïde du 5e métatarse gauche), sous l'hémi-coupole diaphragmatique.
- Foie : Travailler le lobe gauche et l'ensemble du foie pour améliorer la circulation de la veine splénique.

Complément ROP

- Balance Cerveau Limbique-Rate : Technique d'écoute-induction (un pouce sur la rate, l'autre sur le cerveau limbique).



Synthèse : L'Écoute Splénique



Le Pôle Supérieur (Cerveau Limbique)

Régulation émotionnelle, libération des états de rumination et de fatigue profonde.



Le Carrefour Viscéral (Rate & Diaphragme)

Le plancher neuro-végétatif (Th6-Th9, Plexus Coélique). Respecter l'hémodynamique et la fragilité de l'organe.



Le Pôle Inférieur (Appui Podal)

Stimulation à distance via la zone de l'angle splénique (5e métatarsien) et le système porte hépatique.

Complément ROP

Balance cerveau limbique-rate : Pratique de l'écoute-induction avec un pouce sur la zone réflexe de la rate, et l'autre sur la zone du cerveau limbique. Un traitement en douceur, à distance, respectueux de l'architecture vasculaire.

Synthèse Clinique ROP



L'Approche Holistique

La rate ne s'isole jamais. Son traitement passe par l'harmonisation de l'ensemble de sa zone d'écoute : complexe costo-vertébral (Th6-Th11), diaphragme gauche et plexus coeliaque.



La Règle de Prudence

Un organe fragile et hautement vascularisé. Le praticien opère par exclusion (splénomégalie, traumatisme, mononucléose active) et privilégie toujours toujours une action à distance non agressive.



Le Levier Post-Infectieux

L'indication reine en ROP. La rate est le centre de gravité thérapeutique pour relancer la vitalité face à une grande fatigue, un déficit immunitaire ou une récupération post-virale.